

Recomendaciones tratamiento con Harmony Er:YAG

Indicaciones

- Resurfacing facial
- Cicatrices, incluyendo secuelas de acné
- Estrías atróficas
- Vaporización de lesiones benignas

Materiales e insumos

- Tratamiento
 - Guantes y barbijo para el profesional.
 - Vincha y/o cofia.
 - Anestesia tópica (ej. Binaff, Pliaglis o EMLA) para tratamientos pixelados.
 - Anestesia inyectable en caso de lesión benigna voluminosa.
 - Solución antiséptica de limpieza y desinfección (ej. clorhexidina no jabonosa).
 - Papel para secar, paños de gasa, esponjas y algodón.
 - Bowl con solución fisiológica fría.
 - Baja lenguas o espátulas.
 - Crema reparadora, vaselina sólida y ácido fusídico crema.
 - Papel film y cinta hipoalergénica para oclusión en caso de tratamiento corporal u vaporización de lesión benigna.
- Kit de cuidado e higiene para el domicilio del paciente (sugerido)
 - Paños de gasa.
 - Solución antiséptica de limpieza y desinfección (ej. clorhexidina no jabonosa).
 - Crema reparadora, vaselina sólida y ácido fusídico crema.
 - Papel film y cinta hipoalergénica para oclusión en caso de tratamiento corporal u vaporización de lesión benigna.
- Limpieza y desinfección de TIPs y lentes internas
 - Alcohol etílico al 70[%] (desinfección de TIPs en contacto con la piel).
 - Alcohol etílico al 70[%] e hisopos largos (limpieza de lentes internas de TIPs del cabezal).

Precauciones

- No realice tratamientos sobre toxina botulínica o ácido hialurónico durante dos semanas posteriores a su aplicación.
- Evitar aspirina y antiinflamatorios 48[hs] antes del tratamiento.
- Si existe antecedente de herpes simples, comenzar con profilaxis el día previo al tratamiento, un comprimido por día (ej. Veltrex500 o Velaciclovir500) durante una semana.
- En caso de reacción aguda al tratamiento se sugiere corticoide tópico por ejemplo Hidrocortisona 1[%].
- En caso de picazón se sugiere antihistamínico se sugiere Loratadina 10[mg] un comprimido por día.

- Asegurarse de que el paciente no tenga delineado permanente en ojos, cejas o labios. Si es así evitar la zona.
- Fototipo IV o mayor existe riesgo de hiperpigmentación post-inflamatoria.

Preparación

- En pieles hiperqueratósicas o engrosadas es recomendable realizar una exfoliación previa con el fin de eliminar el estrato corneo para maximizar la penetración del láser (opcional).
- El tratamiento local con ácido glicólico y/o retinoico en baja concentración por la noche 15 días antes de la sesión permite preparar la piel para el tratamiento (opcional).
- Un pre-tratamiento con despigmentantes (ej. hidroquinona), para fototipos III a IV o pieles con fotodaño, puede ser útil para reducir el potencial riesgo de hiperpigmentación (opcional).
- Indicar siempre hidratación/humectación diaria y adecuada de la piel con fotoprotección.
- Indicar al paciente que concurra sin lentes de contacto. Retirar todos los accesorios como aros, colgantes, etc.
- Dentro de lo posible que el paciente prevea el regreso a casa sin conducir automóviles.
- El paciente debe tener su casa las cremas, antisépticos y paños de gasa, necesarios para sus cuidados e higiene de la primera semana. *Ver cuidados posteriores del paciente en su domicilio.*

Tratamiento

- Verificar el buen estado general de los TIPs del cabezal. Las lentes internas deben encontrarse limpias y sin daño.
- La zona de tratamiento debe estar libre. Colocar cofia o vincha al paciente. Limpiar la piel retirando maquillaje, lociones, perfume, etc.
- Examinar la piel. No pueden existir alteraciones (fuera de lo esperado según indicación) en la zona de tratamiento.
- Colocar anestesia tópica y ocluir (seguir recomendaciones del fabricante) antes de comenzar el tratamiento.
- Retirar la crema anestésica con un producto no alcohólico (ej. solución de clorhexidina no jabonosa). En caso de un tratamiento que implica múltiples zonas la crema anestésica podría removerse por zona.
- Asegurarse de secar bien la piel antes de comenzar el tratamiento para garantizar una correcta interacción entre el láser y la piel.
- Realizar el tratamiento bajo criterio médico. Configurar los parámetros de tratamiento (energía y modo de emisión) en función de la indicación particular y la guía de protocolos.
- Se recomienda enfriar la piel con Cryo ZIMMER o similar durante el tratamiento.
- La respuesta espera por parte de la piel al tratamiento será eritema y edema. Si se detectaran respuesta aguda o anormal, detener el tratamiento.

Cuidados posteriores en el consultorio

- Una vez terminado el tratamiento, opcional colocar compresas empapada en solución fisiológica fría sobre la zona tratada o aplicar aire frío con un equipo Cryo ZIMMER o similar. Evitar colocar hielo de forma directa sobre la piel.
- Luego de disminuir la incomodidad y el calor, colocar una delgada capa de crema antibiótica (ej. Fusidín crema), posteriormente una delgada capa de crema regeneradora (ej. Aquaphor gel, Bepanthen o Cicaplast) o vaselina sólida.
- En caso de tratamiento corporal ocluir con papel film y cinta hipoalergénica.
- Evitar la exposición solar directa y fuentes de calor los días posteriores.
- Indicarle los cuidados a seguir en el hogar dependiendo del tratamiento realizado. Ver *cuidados posteriores del paciente en su domicilio*.

Evolución

Inmediatamente luego de la sesión existirá eritema moderado o intenso. El paciente sentirá ardor, picazón y calor durante 2 o 4 horas que cederá espontáneamente. La incomodidad será menor si la zona se enfría.

Dependiendo de la agresividad del tratamiento el periodo de recuperación puede ser de 2 hasta 7 días tiempo durante el cual el paciente deberá seguir los cuidados específicos y obligatorios.

El edema aparece de forma tardía al enrojecimiento y se intensifica a la mañana siguiente. En caso de hinchazón severa, especialmente en párpados, se recomienda citar al paciente para drenaje linfático manual.

A partir del segundo o tercer día se generan costras. Pueden realizarse limpiezas suaves de la piel para acelerar la descamación.

La intensidad de estas reacciones dependerá de la técnica y protocolo aplicado. Debe realizarse el seguimiento del paciente durante la recuperación para verificar el correcto cuidado de la piel hasta que haya sanado completamente.

Cuidados posteriores del paciente en su domicilio

- Durante el período de recuperación el paciente debe suspender completamente el uso de productos de su rutina diaria, en particular ácidos tópicos, y solo seguir los cuidados recomendados.
- No exponerse a fuentes de calor. Durante las duchas evitar el vapor y el agua caliente sobre el rostro al menos por tres días luego del tratamiento. Esto exacerbará la sensación de ardor e incomodidad. Evitar además las bebidas alcohólicas.
- Si la sensación de picazón se torna demasiado incómoda tomar un comprimido por día de Loratadina 10[mg].
- Si el tratamiento fue intenso, al menos el primer día, el paciente deberá dormir con dos almohadas para minimizar el edema.
- Evitar la luz solar. No realizar deporte o actividades al aire libre de 2 a 5 días luego del tratamiento para evitar la posible pigmentación post-inflamatoria. Estas actividades podrán retomarse cuando pueda aplicarse protector solar.
- El paciente deberá realizar la siguiente rutina por el día y la noche:
 - Retirar la capa de crema o vaselina con espátula o el borde de una cuchara.

- Limpiar suavemente la zona tratada con una gasa embebida en una solución de clorhexidina no jabonosa.
- Aplicar una delgada capa de ácido fusídico en toda la zona, friccionando suave para que penetre la crema.
- Aplicar crema regeneradora (ej. Aquaphor gel, Bepanthen o Cicaplast) o vaselina sólida. Repetir la aplicación varias veces al día a demanda. Es fundamental que la piel se mantenga sumamente húmeda para evita la sensación de sequedad y tirantez.
- En caso de tratamiento corporal ocluir con papel film y cinta hipoalergénica.
- Una vez que se generen las costras sobre la piel puede realizarse limpiezas suaves con gasa humedecida en la solución de clorhexidina no jabonosa. No intentar arrastrar las costras, las mismas se desprenderán naturalmente. Continuar con la hidratación de la piel para favorecer el desprendimiento de las costras.
- El paciente puede comenzar con el uso de protector solar al finalizar la fase de cura húmeda (exudación). En la etapa previa el uso de protector puede generar ardor.
- Entre el tercero y sexto día, luego de que se caigan las costras, la fotoprotección será obligatoria para proteger la nueva piel. Se puede aplicarse una crema hidratante y maquillaje compacto con protección solar ISDIN40, Avene50 o LaRochePosay, el cual deberá renovarse cada dos horas.
- El proceso de regeneración y mejora del aspecto de la piel puede actuar hasta tres meses.
- Los controles posteriores al tratamiento se realizarán:
 - A las 24 y 48 horas, para controlar la respuesta aguda de la piel. Realizar limpieza y drenaje linfático de ser necesario.
 - A los 4 o 7 días, para controlar que los cuidados a cargo del paciente se estén llevando a cabo correctamente.
 - A los 14 días, opcional, dependiendo de la evolución del paciente.
 - Al mes, para evaluar resultados y, si corresponde, realizar una nueva sesión.